

GOLD T®

MINI — CU 375 MM² + AU

Bakırın etkisi, altın çekirdeğin dayanıklılığı.

Gold T® Mini — hormonsuz bakırlı rahim içi araç · 375mm² aktif bakır · 0,1mm altın çekirdek · en çok 5 yıl

Sistemik hormon içermez; adet siklusu ve doğal hormon dengesi korunur. Koruyucu etki yerleştirme anında başlar. Mini boy, 24mm genişliğiyle küçük uterus kavitesi için ölçeklendirilmiş seçenektir.

375mm² aktif bakır | %99,99 bakır saflığı | 0,1mm altın çekirdek | en çok 5 yıl
MINI 24 x 30,5mm | NORMAL 31 x 33mm | Ref. 01040200 | GTIN 8436021830173

EUROGINE, S.L. · Castelldefels, Barcelona · İspanya

CE 0318 · MDR Class III · etilen oksit ile steril · tek kullanımlık



Gold T® Mini nedir?

Hormonsuz bakırlı RİA — bakır telin merkezinde 0,1mm altın çekirdek, T/Y formunda esnek çerçeve.

375mm²

aktif bakır yüzey

%99,99

bakır saflığı

0,1mm

altın çekirdek çapı

5 yıl

en uzun kullanım süresi

Gold T® Mini, gebelikten korunmaya yönelik **hormonsuz** bir rahim içi araçtır. Baryum sülfat katkılı polietilen çerçevenin dikey gövdesi, aktif yüzeyi **375mm²** olan yüksek saflıkta (%99,99) bakır telle sarılmıştır. **Bu telin merkezinde 0,1mm çapında altın bir çekirdek bulunur.**

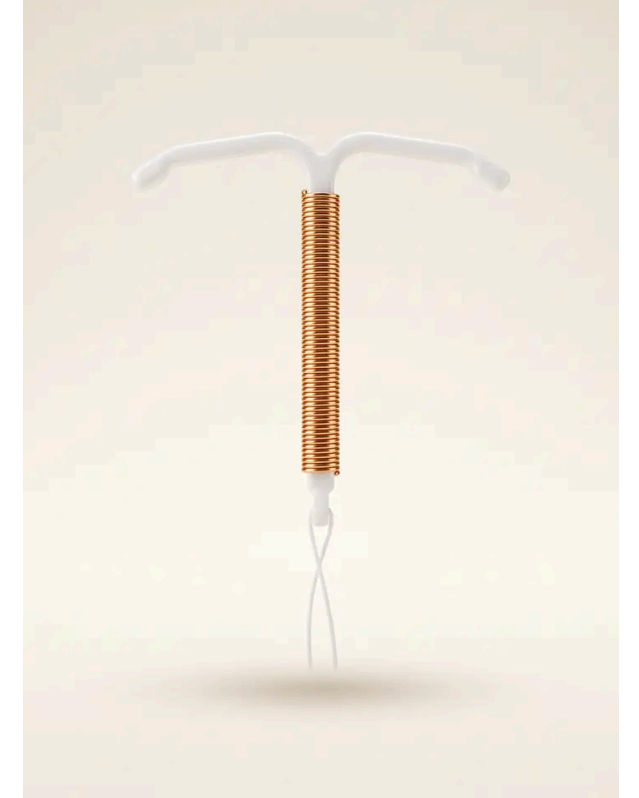
Altın, kontraseptif etkiye katkı vermez; üreticinin bildirdiği işlevi, bakır telin korozyona bağlı parçalanmaya karşı direncini artırmaktır. **Kontraseptif aktif yüzey yalnızca bakırdır.**

Kadın doğum uzmanı tarafından uterus kavitesine yerleştirilir ve koruyucu etkisini hemen gösterir; çıkarıldığında doğurganlık gecikmeden geri döner.

İKİ YÖNLÜ KORUYUCU ETKİ

- 1 Sperm:** salınan bakır iyonları spermin hareketliliğini ve yön bulmasını bozar; fertilizasyon büyük ölçüde gerçekleşmez — **primer etki fertilizasyon öncesidir.**
- 2 Endometrium:** bakır iyonlarının yarattığı lokal steril inflamatuvar ortam, döllenmiş bir yumurtanın implantasyonunu da engeller.

Etki mekanizması bakır iyonlarına bağlıdır ve hormonal değildir; ovulasyon baskılanmaz, adet siklusu devam eder.



T/Y formunda polietilen çerçeve · 375mm² bakır tel · altın çekirdek · çıkarma iplikleri — temsilî ürün görseli.

Teknik künye ve ürün kodları

Tedarik, ruhsat ve hasta dosyası için tek sayfalık referans.

CİHAZ KÜNYESİ	
Üretici	EUROGINE, S.L. — Castelldefels, Barcelona / İspanya
Model	Gold T® Mini (Cu 375 + Au)
Üretici referansı	01040200
GTIN / EAN	8436021830173
PZN (Almanya)	14057156
Eski İspanyol C.N.	337793.5
Boyut (genişlik x uzunluk)	24 x 30,5mm
Aktif bakır yüzey	375mm ²
Bakır saflığı	%99,99
Altın çekirdek çapı	0,1mm
Bakır tel çapı / uzunluğu	0,4mm / 302mm (Rev. 11/2020 föy)
Çerçeve	Polietilen + baryum sülfat (radyopasite)
Çıkarma ipliği	Polietilen, 0,25mm x 450mm (2 adet)
İnserter kanülü	Polietilen, dış çap 3,8mm
İnserter gövdesi	ABS · histerometri skalası 5–10cm (0,5cm)
Sterilizasyon	Etilen oksit · tek kullanımlık
Kullanım süresi	En çok 5 yıl
Sınıf / işaret	MDR (AB) 2017/745 Class III · CE 0318

PORTFÖYDEKİ DİĞER BOYLAR

01040100 · Normal

31 x 33mm — güncel katalogda

01040000 · Maxi

36,5 x 38mm — eski föylerde; güncel 2026 kataloğunda yer almıyor

Her üç boyda da aktif bakır yüzey 375mm² olarak bildirilmiştir; boy lar kaviteye uyumu değiştirir, bakır yükünü değil.

Belge farkı — dikkat

Eurogine'in **Rev. 11/2020** teknik föyünde açıklama metninde **375mm²**, teknik tablo satırında ise **380mm²** yazmaktadır.

Üreticinin 2024–2026 tarihli güncel katalog ve hasta bilgilendirme belgeleri tutarlı biçimde **375mm²** bildirir. Bu broşürde ve hekim iletişimde **375mm²** esas alınmalıdır.

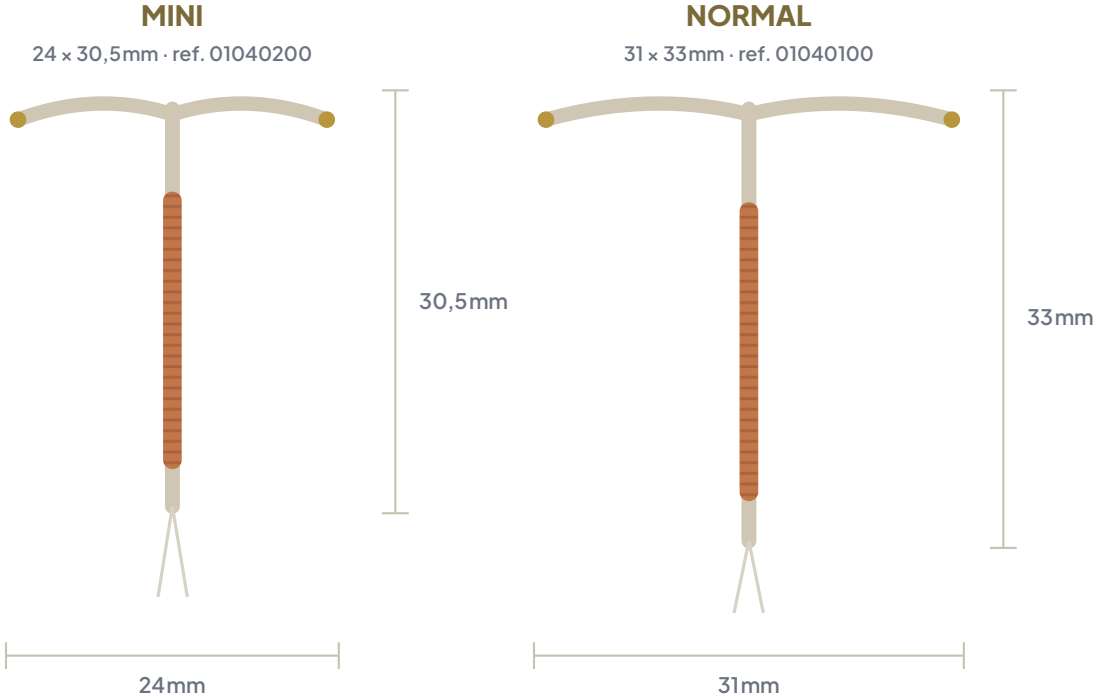
KUTU İÇERİĞİ VE ETİKETLEME

Steril tek kullanımlık blister ambalaj, önceden yüklenmemiş cihaz + inserter, çok dilli hasta bilgilendirme formu ve hasta kartı (yerleştirme ve kontrol tarihi).

MDR Madde 18 kapsamında Class III implante edilebilir cihazlarda hasta kartı (implant card) zorunludur; lot numarası hasta dosyasına kaydedilmelidir.

İki boy — karar histerometriye göre

MINI 24 x 30,5mm · NORMAL 31 x 33mm — her iki boyda da 375mm² bakır ve 0,1mm altın çekirdek.



Temsilî şema — ölçekli (5,2px/mm). Bakır sargı yalnızca dikey gövdededir; kollar bakır içermez.

BOY KARARI

- **MINI 24 x 30,5mm** — dar/küçük kavite, nullipar veya adölesan hastada tercih edilen boy.
- **NORMAL 31 x 33mm** — standart kavite genişliğinde.
- Karar, **başarılı histerometri** sonrasında verilir; cihaz inserter üzerindeki 5–10cm skala ile fundusa yerleştirilir.

IFU'dan doğrulayın

Üretici, Gold T için boy başına **sayısal kavite uzunluğu eşliği** yayımlamamaktadır. Eşik değer için ürünle gelen güncel IFU esas alınmalı; sınıf pratiğinde TCu380A tipi cihazlarda 6–9 cm sonda önerilir; 6 cm altındaki kavitede ekspulsiyon, kanama ve perforasyon sıklığı artar.

ETKİNLİK VE SÜRE

Üretici Gold T için ürüne özel bir Pearl indeksi yayımlamaz. Sınıf referansı olarak **EURAS-IUD** çalışmasında, 58.324 kişilik doğrulanmış RİA kohortu içindeki **bakırlı RİA kullanıcılarında** Pearl indeksi **0,52** (%95 GA 0,42–0,64) bildirilmiştir — hormonal uzun etkili yöntemlerle aynı güvenilirlik aralığı.

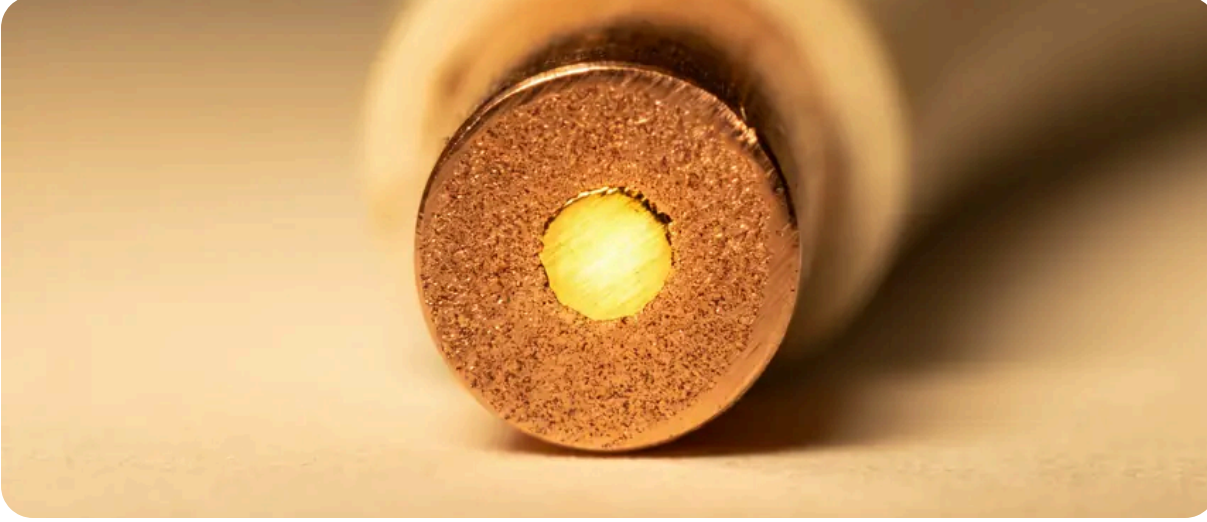
Kullanım süresi **en çok 5 yıl**; hekim tarafından her zaman çıkarılabilir, çıkarım sonrası doğurganlık gecikmez.

Not: Gold T'nin etiket süresi 5 yıldır; TCu380A'nın 10 yıllık etiketi bu ürün için geçerli değildir.

Heinemann K ve ark. Contraception. 2015;91(4):280–283. DOI: 10.1016/j.contraception.2015.01.011

Altın çekirdek ne işe yarar?

Kontraseptif yüzey bakırdır; altın, telin mekanik ve korozyon dayanımı için merkeze yerleştirilmiştir.



Bakır telin kesiti: merkezde 0,1mm çapında altın çekirdek — temsili makro görsel.

Neden altın? Bakır, uterus içinde iyon salarken yüzeyinden aşınır. Eurogine, telin merkezine korozyona uğramayan ve biyoyumlu altın bir çekirdek yerleştirerek telin **ikincil fragmentasyona** (parçalanmaya) karşı direncini artırmayı hedeflediğini bildirir.

Ürün, Eurogine'in bildirimine göre **1998–1999'da Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ve CDTI** iş birliğiyle geliştirilmiştir ve üretici tarafından "altın çekirdekli bakır tele sahip tek RİA" olarak tanımlanır.

Hekime net üç cümle

- Altın **kontraseptif etki üretmez**; aktif yüzey 375mm² bakırdır.
- Üretici altın için **antibakteriyel, anti-inflamatuvar veya tedavi edici bir iddia bildirmez**; belirtilen tek işlev mekanik/korozyon dayanımıdır.
- Hormon içermez; ovulasyon ve adet siklusu korunur.

Karşı hipotez — dosyaya alın

2025 tarihli tek merkezli retrospektif bir çalışma, altın çekirdeğin çerçeve esnekliğini azaltarak dikey gövde ile kolların birleşme noktasında (T-bileşkesi) **gerilim yoğunlaşmasına** yol açabileceğini öne sürmüştür.

Aynı çalışmada Gold T® **Normal** kullanıcılarında %6,56 spontan kırılma bildirilmiştir; karşılaştırılan altın çekirdeksiz cihazda kırılma görülmemiştir.

Bu, üreticinin dayanıklılık gerekçesiyle doğrudan çelişen tek yayındır ve ürün değerlendirmesinde atlanmamalıdır. Ayrıntı, çalışma sınırlılıkları ve klinik öneri için **sayfa 11**.

Semiz A, Özbay K. Med Sci Monit. 2025;31:e950460. DOI: 10.12659/MSM.950460

Yerleştirme sistemi

3,8mm kanül, ayarlanabilir flanş ve gövde üzerinde 5–10cm histerometri skalası.



İnserter ve ölçekli gövde — temsili görsel. Cihaz kullanım öncesinde hekim tarafından yüklenir.

SİSTEMİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- **Dış çapı 3,8mm** polietilen kanül.
- Gövde üzerinde **5–10cm** aralığında, 0,5cm bölmeli histerometri skalası.
- **Hareketli piston:** histerometri sonucuna ayarlanan flanş ile fundal yerleşimi hedefler.
- ABS gövde, tek kullanımlık, etilen oksit ile steril.
- İnserter tasarımı **ADI-FAD Delta Ödülleri 2013 seçkisinde** yer almıştır (tasarım: Enric Dachs Roig, Núria Coll Campmany).

ÜRETİCİ İDDİASI — OKUMA NOTU

Eurogine'in eski belgelerinde sistemin "başarılı histerometri sonrası perforasyonu tümüyle imkânsız kıldığı" ifadesi geçer. Üreticinin güncel belgelerinde bu ifade "**riski azaltır/en aza indirir**" biçiminde ölçülmüştür. Hekim iletişimde güncel, ölçülü ifade kullanılmalıdır.

NAZİK UYGULAMA — SAHADA

Bimanuel muayene > Spekulum > Antisepsi > Tenakulum > Histerometri > Flanşı ölçüye ayarla > No-touch yükleme > Fundusa yerleştir > İpliği 2–3cm bırak

Pelvik enfeksiyon riski esas olarak yerleştirmeyi izleyen ilk 20 güne sınırlıdır ve %1'in altındadır; rutin antibiyotik profilaksisi önerilmez. Ağır dismenore öyküsünde ağrı planı yerleştirme öncesinde konuşulmalıdır. Lot numarası hasta dosyasına ve hasta kartına kaydedilir.

Sistemik hormon sıfır.

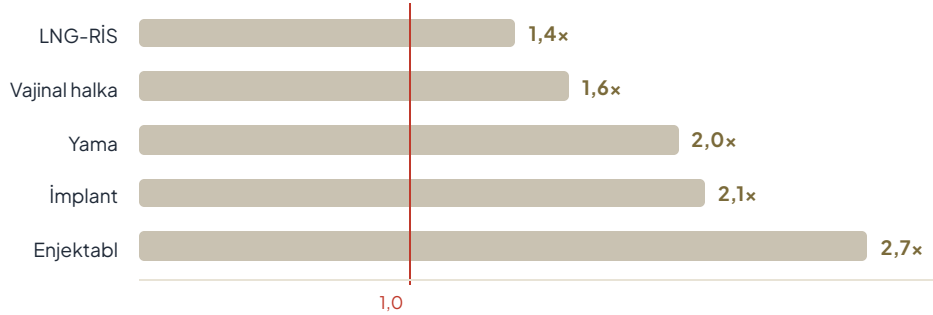
Adet siklusu korunur; hormonal yan etki ve kontrendikasyon tartışması bu ürüne uygulanmaz.

Gold T® Mini levonorgestrel ya da başka bir steroid içermez. İnce bakır tel, endometriyal ortamı değiştiren düşük miktarda bakır iyonunu sürekli salar; **ovulasyon baskılanmaz, adet devam eder.**

“Sistemik hormon yok — adet korunur; ruh hali, libido ve kilo tartışması bu ürüne uygulanmaz.”

Depresyon, duygudurum değişikliği, libido kaybı veya kilo artışı gibi hormonal yan etkiler beklenmez.

Hormonal kontrasepsiyon ve ilk antidepresan kullanımı (Skovlund 2016; 1.061.997 kadın)



Düzeltilmiş insidans hız oranları; gözlemsel kohort verisi. Bakırlı RİA hormon salmadığı için bu karşılaştırmanın dışındadır.
Skovlund CW ve ark. JAMA Psychiatry. 2016;73(11):1154–1162. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2016.2387

HEKİM VE HASTA İÇİN PRATİK KARŞILIKLAR

- **Kullanıcı hatasına kapalı** — günlük/aylık uyum gerektirmez.
- **5 yıla kadar** tek uygulamayla koruma.
- Adet düzeni ve ovulasyon korunur; amenore beklenmez.
- Emzirmede hormon geçişi sorunu yoktur; laktasyon etkilenmez.
- Hormonal kontrendikasyonu olan hastada **tek hormonsuz uzun etkili geri dönüşlü seçenek grubundadır.**
- İlaç etkileşimi (enzim indükleyiciler) etkinliği değiştirmez.
- Hekim tarafından her zaman çıkarılabilir; doğurganlık gecikmez.
- Aylık maliyeti diğer yöntemlere göre düşüktür.

Beklenen yan etki: bakırlı RİA'da ilk 3–6 ayda adet miktarında artış ve dismenore sıklaşması olabilir; bu, yöntemle bağlı en sık bırakma nedenidir ve yerleştirme öncesinde konuşulmalıdır.

Hormonun kontrendike olduğu hastada tam etkinlik.

Bakırlı RİA'yı LNG-RİA'dan ayıran, uygunluk kriterleri ve adet paterni üzerindeki farktır.

CDC U.S. MEC, 2024 — meme kanseri kategorileri

DURUM	BAKIRLI RİA	LNG-RİA
Mevcut meme kanseri	1 — kullanımda kısıtlama yok	4 — kabul edilemez sağlık riski
Geçmiş meme kanseri, 5 yıl bulgu yok	1	3
Venöz tromboemboli öyküsü / auralı migren	1	2

Kategori 1: kısıtlama yok · 2: yarara ağır basar · 3: risk yarara ağır basar · 4: kabul edilemez risk. Kaynak: U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024.

Hormonun kontrendike / istenmediği hastalar

- Aktif veya geçirilmiş meme kanseri
- VTE öyküsü, trombofili, auralı migren
- Ağır karaciğer hastalığı
- 35 yaş ve üzeri sigara kullanımı, kontrolsüz hipertansiyon
- Enzim indükleyici ilaç kullanımı
- Emziren anne — laktasyon etkilenmez, bebeğe hormon geçişi olmaz

Mørch ve ark., 2024 · JAMA

78.595 LNG-RİA kullanıcısı, hormonal kontrasepsiyon kullanmayan eşit sayıda kadınla eşleştirildi: LNG-RİA kullanımı meme kanseri ile **HR 1,4 (%95 GA 1,2–1,5)** ilişkili bulundu.

Araştırma mektubu (research letter) formatındadır.

JAMA. 2024;332(18):1578–1580. DOI: 10.1001/jama.2024.18575

Liu ve ark., 2024 · eClinicalMedicine

20 randomize çalışmanın meta-analizinde **amenore nedeniyle yöntemi bırakma**, LNG-RİA grubunda bakırlı RİA grubuna göre belirgin yüksekti: **RR 21,05 (%95 GA 8,83–50,00)**.

Bakırlı RİA adet paternini korur.

eClinicalMedicine. 2024;78:102926. DOI: 10.1016/j.eclinm.2024.102926

Gold T® Mini bu hastada ne sunar?

Levonorgestrel içermez. 375mm² bakır yüzeyle 5 yıla kadar uzun etkili, geri dönüşlü ve kullanıcı hatasına kapalı korunma sağlar.

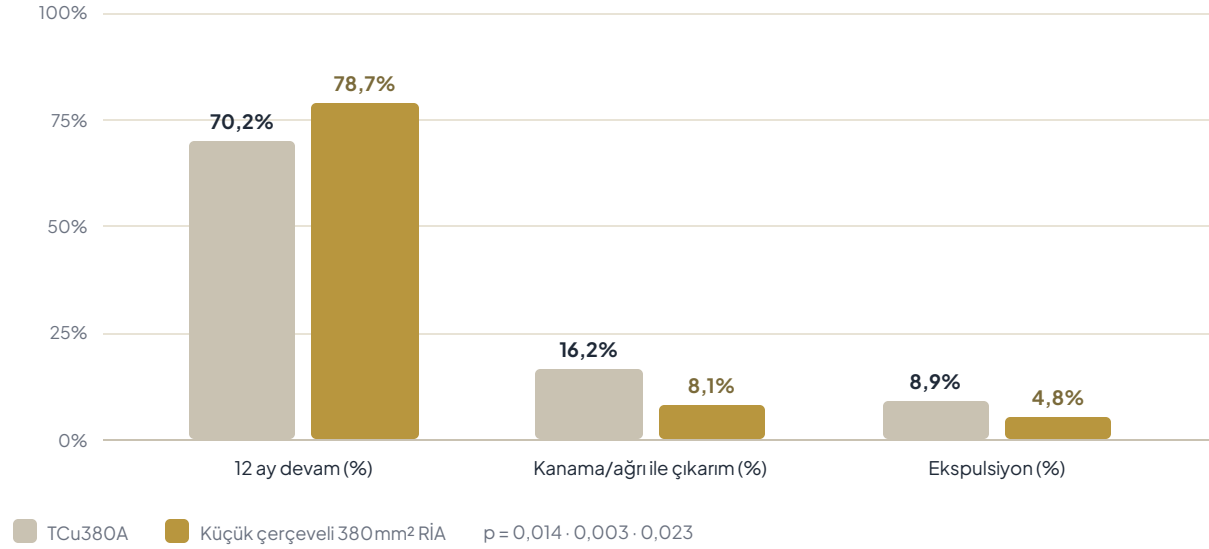
Hormon istemeyen, adetinin devamını önemseyen ya da LNG-RİA'nın uygun olmadığı hastada **hormonal risk tartışmasının tümüyle dışında kalır**.

Kontrendikasyonlar (gebelik, açıklanamayan vajinal kanama, aktif pelvik enfeksiyon, kaviteyi bozan uterin anomali, Wilson hastalığı, bakır alerjisi) yerleştirme öncesi dışlanmalıdır.

MINI boyu destekleyen sınıf verisi

Nullipar ve dar kavitede küçük çerçeveli bakırlı RİA'lar daha iyi tolere ediliyor.

Nulliparda küçük 380mm² RİA (NT380-Mini) vs TCu380A — randomize, 927 randomize / 908 analiz (Hubacher 2022)



Çalışmadaki cihaz **NT380-Mini**'dir; Gold T® Mini değildir. Veri, **küçük çerçeve boyutlandırma yaklaşımının** nulliparda daha iyi tolere edildiğini gösteren sınıf kanıtıdır.

Hubacher D ve ark. eClinicalMedicine. 2022;51:101554. DOI: 10.1016/j.eclinm.2022.101554

Akintomide ve ark. , 2022 · BMJ Open

13.045 nullipar kadını kapsayan 19 çalışmalık sistematik derlemede, 12 aylık **en yüksek devam oranı** daha küçük TCu380A tipinde **%91,02** (%95 GA 88,01–93,64) olarak bildirildi.

BMJ Open. 2022;12(10):e060606. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-060606

Gold T® Mini'nin portföydeki yeri

24mm genişlik, bu literatürün işaret ettiği küçük çerçeve aralığındadır ve nullipar ya da dar kaviteli hastada ayrı bir seçenek sunar.

ACOG: RİA'lar nullipar kadınlara ve adölesanlara güvenli ve etkili seçenek olarak rutin biçimde sunulmalıdır (Practice Bulletin 186, 2017; Committee Statement No. 5, 2023).

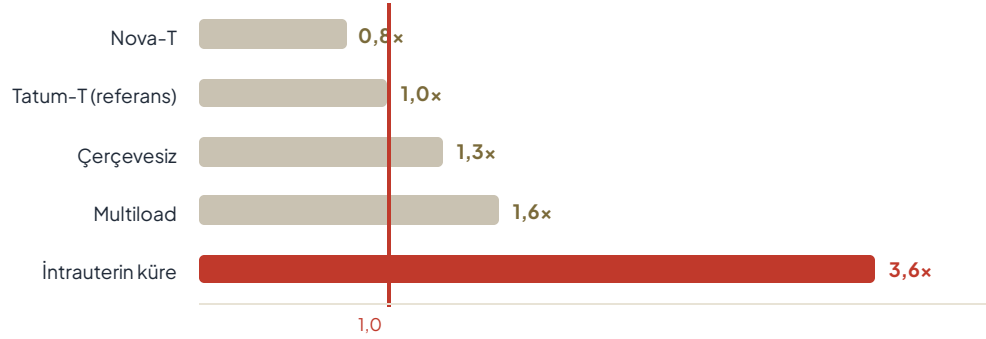
Dürüst okuma

Gold T® Mini için **ürüne özgü randomize karşılaştırmalı çalışma yayımlanmamıştır**. Bu sayfadaki veriler benzer boyut sınıfındaki bakırlı RİA'lara aittir ve doğrudan Gold T Mini sonucu olarak sunulamaz.

Çerçeve geometrisi ve ekspulsiyon

Cihaz şekli ekspulsiyon riskini değiştirir; kollu klasik geometriler küresel tasarımlardan üstündür.

Ekspulsiyon — cihaz şekline göre düzeltilmiş HR (Boehnke 2024; 26.381 bakırlı RİA kullanıcısı; referans Tatum-T)



Gold T®, küresel olmayan, kollu klasik T/Y geometrisindedir. Analizde Gold T'ye özgü bir alt grup yoktur; veri şekil sınıfı düzeyindedir.

Boehnke T ve ark. Contraception. 2024;140:110444. EURAS-LCS12 kohortu. DOI: 10.1016/j.contraception.2024.110444

Foran ve ark., 2018 · sistematik derleme, nullipar

LEHTE

- Enfeksiyon oranlarında pariteye göre fark yok.
- Ekspulsiyon oranlarında nullipar-parous farkı yok.
- Çıkarım sonrası fertilité genel popülasyonla benzer.

AYNI DERLEMEDE

- Nulliparda **yerleştirme güçlüğü, başarısız yerleştirme ve yerleştirme ağrısı daha sık.**
- Derlemeye giren çalışmaların metodolojik kalitesi düşük değerlendirildi.

Eur J Contracept Reprod Health Care. 2018;23(5):379–386. DOI: 10.1080/13625187.2018.1526898

Akintomide ve ark., 2021 · EURAS-IUD alt analizi

30 yaş altı 5.762 bakırlı RİA kullanıcısında, daha yüksek devam ve daha az istenmeyen etki ile ilişkili bulunan cihaz özellikleri:

- **18 – <30mm genişlik** — Gold T Mini 24mm ile bu aralıktadır. **uyumlu**
- **Esnek kollar** — Gold T'nin kolları esnektir. **uyumlu**
- **<300mm² bakır içeriği** — Gold T 375mm²'dir. **uyumlu değil**
- **At nalı çerçeve tasarımı** — Gold T T/Y formundadır. **uyumlu değil**

Bu analiz Gold T Mini'yi tümüyle desteklemez: dört özellikten ikisi uyumludur. Bakır yükünün azalması etkinliği de düşürebileceğinden düşük bakır içeriği tek başına bir üstünlük olarak sunulmamalıdır.

Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021;26(3):175–183. DOI: 10.1080/13625187.2021.1879783

EKSPULSİYON RİSKİNİ AZALTAN PRATİK

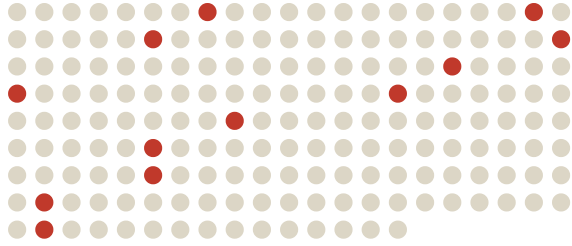
- Kaviteye uygun boy seçimi (histerometri).
- Fundal yerleşim — flanşın ölçüye ayarlanması.
- Ağır menstrüel kanama ve ilk 3 ay yakın takip.
- 1. ay kontrolü + yıllık ultrasonografik değerlendirme.

Spontan kırılma — dosyaya girmesi gereken yayın

2025 tarihli tek merkezli retrospektif çalışma, Gold T® Normal kullanıcılarında %6,56 spontan kırılma bildirdi.

Semiz & Özbay, 2025 · Medical Science Monitor

Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul · 2011–2021 · 463 kadın · retrospektif kohort



183 Gold T Normal kullanıcısı

■ 12 spontan kırılma

6,56%

Gold T® Normal (Cu 375 + Au) — 12 / 183 kullanıcı
%95 GA 2,97–10,15

0%

Flexi-T+ 300 (altın çekirdeksiz, Cu 300) — 0 / 280 kullanıcı

KIRIK PARÇANIN YERİ VE KLİNİK TABLO

9 / 12

uterus kornusunda — histeroskopi ile çıkarıldı

3 / 12

servikal kanalda — Novak ile çıkarıldı

%16,7

semptomsuz; yalnızca rutin kontrolde saptandı
(%83,3 ara kanama/ağır kanama)

Semiz A, Özbay K. Med Sci Monit. 2025;31:e950460. PMID 41275328. DOI: 10.12659/MSM.950460

Çalışmanın sınırlılıkları

- Tek merkez, retrospektif tasarım; randomizasyon yok.
- Yalnızca 2 cihaz modeli karşılaştırıldı.
- Kohort en az bir vajinal doğum yapmış kadınlarla sınırlı; nullipar hasta dışlandı — bulgular MINI'nin hedef grubuna doğrudan genellenemez.
- Kullanım süresi 12–120 ay; bir bölümü 5 yıllık etiket süresinin ötesinde kalmış cihazlar.
- Mekanik dayanım testi yapılmadı; kırılma mekanizması hipotez düzeyinde.
- Çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmadı.

Bu veriyle ne yapılmalı?

- Kırılma semptomsuz olabilir; yıllık ultrasonografik değerlendirme öner.
- Ara kanama veya açıklanamayan pelvik ağrıda cihaz bütünlüğünü görüntüle.
- Etiket süresini aşan kullanımdan kaçın; 5 yılda çıkar.
- Parça görülemiyorsa spontan atılmış olabilir.
- Kornual parçada histeroskopi, kanaldakinde Novak etkilidir.

2018–19 saha güvenlik bildirimi

Belirli üretim lotlarıyla sınırlı, kök nedeni tanımlanmış ve kapatılmış bir olay — ancak hekim bunu bilmeli.

Ne oldu?

Eurogine, 2018–2019'da Ancora, Novaplast ve **Gold T** ailelerini kapsayan bir saha güvenlik bildirimi (FSN) yayımladı. Sorun, çerçeveyi oluşturan **polimer ile baryum sülfat karışımının homojen dağılmaması**ydı: oran doğru, dağılım düzensizdi. Çerçevenin kritik bölgelerinde baryum sülfat kümeleri oluştuğunda **kolların kırılması** mümkün oluyordu.

Kök neden **hammadde tedarikçisinin üretim kusuru** olarak tanımlandı. Kırılma en çok **çıkarma sırasında**, daha az sıklıkla spontan ekspulsiyonla ilişkili biçimde bildirildi.

ETKİLENEN REFERANSLAR

01040000 Gold T Maxi
01040100 Gold T Normal
01040200 Gold T Mini
+ Ancora ve Novaplast modelleri

ETKİLENEN LOTLAR

0114 · 0614 · 1114 · 0415 · 1115 · 0216 · 0616 · 1116 ·
0217 · 0417 · 0917

DÖNEM

2014 – Şubat 2018 arasında piyasaya verilen
belirli lotlar

Bugün ne anlama geliyor?

- Bildirim **tanımlı lotlarla sınırlıdır**; bugün piyasadaki Gold T Mini geri çağırılmış bir ürün değildir.
- Etkilenen lotların raf ömrü dolmuştur; ancak **o dönemde takılmış cihazlar hâlâ hastalarda olabilir**.
- Bildirim, ürünün **çerçeve dayanımının** izlenmesi gereken bir parametre olduğunu göstermiştir.

Bildirimi yayımlayan otoriteler

AEMPS (İspanya)

Bilgilendirme notu NI-PS 24/2019 — DIU Eurogine

BfArM (Almanya)

Acil saha güvenlik bildirimi 01783/18

FSRH CEU (Birleşik Krallık)

Klinik görüş bildirisi, Mayıs 2021

Klinikte ne yapılmalı?

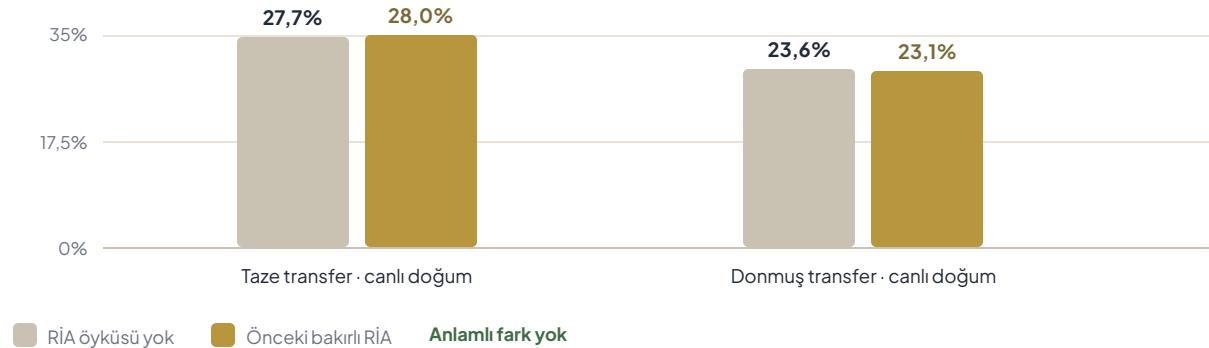
- Her yerleştirmede **lot numarasını** hasta dosyasına ve hasta kartına yaz.
- 2014–2018 arasında Eurogine RİA takılmış hastada çıkarmı **kontrollü koşullarda** planla; kırık parça ihtimalini öngör.
- Çıkarımda direnç veya eksik parça varsa **görüntüleme + histeroskopi** için hazırlıklı ol.
- Tedarikte **güncel lot ve seri takibi** ile üreticinin uygunluk beyanını iste.
- Ürün şikâyetini üreticiye ve TİTCK'ya bildir.

Her yaştan kadın için

IVF arası dönem, acil kontrasepsiyon, emzirme ve perimenopoz.



IVF/ICSI sonrası canlı doğum — önceki bakırlı RİA kullanımı (Huang 2026; 62.422 embriyo transfer siklusu)



Düzeltilmiş risk oranları: taze aRR 1,01 (%95 GA 0,91–1,11); donmuş aRR 0,97 (0,87–1,07). Önceki bakırlı RİA kullanımı IVF sonuçlarını etkilememiştir. **IVF planlanan hastada ara dönem kontrasepsiyonu; stimülasyon öncesi çıkarılır.**

Huang W ve ark. Front Cell Dev Biol. 2026;14:1790194. DOI: 10.3389/fcell.2026.1790194

Acil kontrasepsiyonda bakırlı RİA

Randomize çalışmada korunmasız ilişkiden sonraki 120 saat içinde bakırlı RİA takılan **321 hastanın hiçbirinde gebelik görülmedi** (%0; %95 GA 0–1,1) ve aynı uygulamayla 5 yıla kadar kalıcı koruma sağlandı.

IFU'dan doğrulayın Acil kontrasepsiyon, bakırlı RİA sınıfına ait bir uygulamadır; Gold T'nin onaylı endikasyonları için ürün IFU'su esas alınmalıdır.

Turok DK ve ark. N Engl J Med. 2021;384(4):335–344. DOI: 10.1056/NEJMoa2022141

KİMLER İÇİN UYGUN?

- Kavitesi dar olan ve henüz doğum yapmamış kadınlar — **MINI**
- Yakın dönemde gebelik planlamayan veya aile planlamasını tamamlamış kadınlar
- Günlük/aylık uyum istemeyenler
- Meme kanseri, tromboz öyküsü veya ailesel yüksek risk; sigara, kilo, hipertansiyon nedeniyle hormonsuz korunması gerekenler
- Emzirmeyi sürdürmek isteyen anneler — doğum sonrası yerleştirme zamanı için IFU esas alınır
- Perimenopoz: adeti korur, hormon replasman tedavisine hormonal yük eklemeyiz

EUROGINE, S.L. — İspanya

Tasarım, üretim ve kalite kontrol tek tesiste; sterilizasyon sertifikalı dış kuruluştur.

ŞİRKET KÜNYESİ

Ünvan	EUROGINE, S.L. · NIF B59608919
Adres	C. Raurell 21-29, Nave 3 · 08860 Castelldefels, Barcelona / İspanya
Kuruluş	1991
Faaliyet	Jinekolojik cihaz Ar-Ge, üretim ve dağıtım; ağırlıklı olarak bakırlı RİA
İhracat	50'den fazla ülke (Avrupa, Orta Doğu, Asya, Amerika)
Telefon / e-posta	+34 93 630 43 45 · eurogine@eurogine.com

BELGELER VE MEVZUAT

Kalite sistemi	UNE-EN ISO 13485:2018 / EN ISO 13485:2016 / ISO 13485:2016
Sertifika no	2012 01 0006 EN
Kapsam	Tasarım, geliştirme ve aktif olmayan implantların üretimi
Geçerlilik	26 Kasım 2026 (yenilenme durumu tedarik öncesi teyit edilmeli)
Cihaz mevzuatı	MDR (AB) 2017/745 · Class III · CE 0318
Ulusal izin	AEMPS ön sağlık lisansı (İspanya)

Tesiste ne var?

- Valide ve sertifikalı **ISO Sınıf 7 temiz oda**
- Üretim ve montaj hatları
- Kalite kontrol laboratuvarı
- Ar-Ge laboratuvarı
- Depolama ve lojistik
- Periyodik fonksiyonel ve mikrobiyolojik kontrol

Sterilizasyon, valide edilmiş etilen oksit prosesiyle **sertifikalı dış kuruluştur** yapılır; üretim lotları **akredite dış laboratuvar**da mikrobiyolojik kontrolden geçirilir.

Neden Class III önemli?

Bakırlı RİA'lar MDR kapsamında en yüksek risk sınıfındadır. Bu, üretim süreçlerinin sıkı ve sürekli denetimi, tasarım dosyasının onaylı kuruluş tarafından incelenmesi ve **piyasaya arz sonrası izlem (PMS/PMCF) yükümlülüğü** anlamına gelir.

Tedarik görüşmesinde güncel CE sertifikası, ISO 13485 sertifikası, uygunluk beyanı, IFU'nun Türkçe sürümü ve seri/lot izlenebilirliği yazılı olarak istenmelidir.

Ürün kodları, Türkiye durumu ve kontrol listesi

Tedarik görüşmesine bu sayfayla girin.

SİPARİŞ KİMLİĞİ — GOLD T® MINI

Üretici referansı

01040200

Eski İspanyol C.N.

337793.5

GTIN / EAN

8436021830173

Boy - bakır

24 x 30,5mm · 375mm²

PZN (Almanya)

14057156

Ambalaj

1 adet / steril

Üreticiye doğrudan ulaşım

Genel

eurogine@eurogine.com

Sipariş

pedidos@eurogine.com

Uluslararası

worldwide@eurogine.com

Telefon

+34 93 630 43 45 · Pzt-Prş 08:00-16:15, Cu 08:00-14:30 (CET)

Türkiye — doğrulanması gereken alan

Eurogine, uluslararası tanıtım belgelerinde satış yapılan ülkeler arasında Türkiye'yi de sayar. Türkiye'de **Medaks Sağlık** web sitesinde Eurogine rahim içi araçlarını ürün grubu olarak göstermeye devam etmektedir.

Ancak bu sayfa **2017 tarihlidir** ve içeriği güncel değildir: Gold T için **10 yıl** kullanım süresi yazmaktadır; üreticinin güncel belgeleri **en çok 5 yıl** demektedir.

Bu nedenle Medaks'ın bugün hâlâ resmî Türkiye distribütörü/ithalatçısı olduğu yalnız bu web sayfasına dayanarak kabul edilmemelidir.

NASIL DOĞRULANIR?

- TITCK Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydını ve tekil ürün numarasını sorgulayın.
- Üreticiden **güncel ve yazılı distribütörlük teyidi** isteyin.
- Türkçe kullanım kılavuzu ve etiketin mevzuata uygunluğunu belge üzerinden görün.

Tedarik görüşmesi kontrol listesi

- Güncel **CE 0318** sertifikası ve AB uygunluk beyanı
- ISO 13485 sertifikasının **güncel geçerlilik tarihi**
- Türkiye için distribütörlük/ithalat yetkisi
- Türkçe IFU ve etiket örneği
- ÜTS kaydı ve tekil ürün numarası
- Lot izlenebilirliği ve raf ömrü politikası
- 2018-19 FSN sonrası **düzeltilici faaliyet raporu**
- Piyasaya arz sonrası izlem (PMS/PMCF) özeti
- Şikâyet ve ürün geri bildirim kanalı
- Mini / Normal için minimum sipariş ve teslim süresi

GOLD T® MINI

EUROGINE, S.L. · İSPANYA · CE 0318

HEKİME TEK CÜMLE

“Hormonsuz, 5 yıl, kullanıcı hatasına kapalı; 24mm MINI ile dar kavitede de uygulanabilir — hormonun kontrendike olduğu her hastada tam etkinlik.”

Broşürün dürüstlük notu: Bu dosyada üretici beyanları, sınıf düzeyindeki klinik kanıt ve ürünün olumsuz verisi ayrı ayrı işaretlenmiştir. Gold T® Mini'ye özgü randomize klinik çalışma bulunmamaktadır; spontan kırılma verisi (s. 11) ve saha güvenlik bildirimi (s. 12) değerlendirmeye dâhil edilmelidir.

KAYNAKLAR

1. Semiz A, Özbay K. Med Sci Monit. 2025;31:e950460.
2. Heinemann K ve ark. Contraception. 2015;91(4):280–283.
3. Skovlund CW ve ark. JAMA Psychiatry. 2016;73(11):1154–1162.
4. Mørch LS ve ark. JAMA. 2024;332(18):1578–1580.
5. Liu P ve ark. eClinicalMedicine. 2024;78:102926.
6. Hubacher D ve ark. eClinicalMedicine. 2022;51:101554.
7. Akintomide H ve ark. BMJ Open. 2022;12(10):e060606.
8. Akintomide H ve ark. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021;26(3):175–183.
9. Boehnke T ve ark. Contraception. 2024;140:110444.
10. Foran T ve ark. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2018;23(5):379–386.
11. Huang W ve ark. Front Cell Dev Biol. 2026;14:1790194.
12. Turok DK ve ark. N Engl J Med. 2021;384(4):335–344.
13. Cortessis VK ve ark. Obstet Gynecol. 2017;130(6):1226–1236.
14. CDC. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024.
15. ACOG Practice Bulletin No. 186 (2017); Committee Statement No. 5 (2023).
16. AEMPS NI-PS 24/2019; BfArM 01783/18; FSRH CEU bildirisi (2021).
17. Eurogine: 2026 ürün kataloğu, hasta bilgilendirme Rev. 09/2024, teknik föy Rev. 11/2020.

Rahim içi araç kullanımı, rahim ağzı kanseri riskinde azalma ile ilişkili bulunmuştur (Cortessis 2017; özet OR 0,64, %95 GA 0,53–0,77 — RİA genel olarak, bakıra özgü değildir). · Bu doküman hekime yönelik bilimsel bilgilendirme amaçlıdır, hasta tanıtım materyali değildir. Ürün-spesifik endikasyon, kontrendikasyon ve uygulama bilgisi için yürürlükteki kullanım talimatı (IFU) esastır. Görseller temsildir. · Eylül 2026